Verpleegkundige visie in de geestelijke gezondheidszorg

M3/OLOD4 · sınav özeti · Hollandaca cümle (Türkçesi parantez içinde)

Not: Cümleler syllabus'tan alındı. Fotoğrafta sayfa kenarında kesilen cümleleri **…** ile kısalttım. Sarı kutular = ezberlenecek. ★ = notunda "examen" yazan konu.

1. Therapeutische milieus ★ (alle drie kort uitleggen)

- De inhoud van het therapeutisch klimaat wordt bepaald door de problematiek van de zorgvrager of groep zorgvragers en mogelijkheden en beperkingen die hij bezit. (Terapötik iklimin içeriği, hastanın veya grubun sorunu ile sahip olduğu imkân ve kısıtlılıklar tarafından belirlenir.)
- Kerstens en Janzing (2005) onderscheiden het supportief model, het reconstructief model en het sociaal therapeutisch model. (Kerstens ve Janzing (2005) üç model ayırır: destekleyici, yeniden yapılandırıcı ve sosyal-terapötik model.)

Notun: **"Die drie gebruiken elkaar in afdeling"** (Bu üçü serviste birlikte kullanılır)

A) Het supportief model

- Dit is het meest voorkomende therapeutisch milieu in zowel ambulante als residentiële behandelingen. (Bu, hem ayaktan hem yatılı tedavide en sık görülen terapötik ortamdır.)
- In dit model worden zorgvragers opgenomen die geen of een beperkt inzicht hebben in hun problematiek en daardoor geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om voor zichzelf te zorgen. (Bu modelde, sorunlarına dair farkındalığı olmayan ya da az olan ve bu yüzden kendine tamamen/kısmen bakamayan hastalar alınır.)
- Er is een psychopathologie aanwezig die zich situeert op niveau van de persoonlijkheidsstructuur (executief systeem), waardoor ze op dit moment niet in staat zijn om eigen verantwoordelijkheid op te nemen. (Sorun kişilik yapısı düzeyindedir (yürütücü sistem); bu yüzden şu an kendi sorumluluklarını alamazlar.)
- Dit ziet men terugkomen in problematieken als psychose, suïcidaliteit, ernstige depressie,… (Bu; psikoz, intihar eğilimi, ağır depresyon gibi sorunlarda görülür.)
- De focus in de behandeling ligt op het terug zelfstandig functioneren. (Tedavinin odağı yeniden bağımsız işlev görmektir.)
- Kenmerkend voor het supportief milieu is dat men individugericht en antiregressief werkt. (Destekleyici ortamın özelliği bireye yönelik ve gerilemeyi önleyici çalışmaktır.)

Twee polen (technieken tussen 2 polen)

- Technieken die de zorgvrager leren om terug zelfstandig te worden en werken aan een volledig herstel (**ik-opbouw**). → heel belangrijk (Hastaya yeniden bağımsız olmayı öğreten ve tam iyileşmeye çalışan teknikler (**ben'in yeniden inşası**).)
- Technieken die zorgvragers helpen te leven met hun onveranderbare beperkingen, hun psychische invaliditeit (**ik-versterking**). (Değişmeyecek kısıtlılıkla, ruhsal engelle yaşamaya yardım eden teknikler (**ben'in güçlendirilmesi**).)
- …technieken die erop gericht zijn om verdere uitval tegen te gaan (**ik-behoud**). → heel belangrijk (…daha fazla gerilemeyi/işlev kaybını önleyen teknikler (**ben'in korunması**). Notun: hastanın yapabildiğini kendisi yapmasına izin ver.)

Antiregressief werken

- Regressie betekent letterlijk "terugvallen op een vroeger ontwikkelingsstadium". (Regresyon, kelimesi kelimesine "daha eski bir gelişim aşamasına geri düşmek" demektir.)
- Bij volwassenen zien we dit onder de vorm van zelfverwaarlozing (hygiëne, slaappatroon, voeding, daginvulling,…). (Yetişkinlerde bu, kendini ihmal olarak görülür (hijyen, uyku düzeni, beslenme, günlük aktivite).)

- Intensieve zorg: hand-in-hand-begeleiding. (Yoğun bakım: elele rehberlik. (**1. aşama**))
- Leven binnen een leefgroep: individueel behandelprogramma. (Yaşam grubu içinde yaşam: bireysel tedavi programı. (**2. aşama**))
- Werken richting ontslag bij voldoende herstel en evenwicht. (Yeterli iyileşme ve denge olunca taburcuya doğru çalışma. (**3. aşama**))
- Een belangrijk onderdeel is het bieden van structuur: duidelijke weekschema's en afspraken zorgen voor duidelijkheid en voorspelbaarheid. (Önemli bir parça yapı sunmaktır: net haftalık programlar ve anlaşmalar netlik ve öngörülebilirlik sağlar.)
- Aan het hoofd staat een behandelcoördinator: een psychiater of psycholoog. (Başta bir tedavi koordinatörü durur: psikiyatrist ya da psikolog.)

B) Het reconstructieve model

- Binnen dit reconstructieve model staat psychotherapie centraal. (Bu yeniden yapılandırıcı modelde psikoterapi merkezdedir. (Notun: schematherapie; geçmiş kişiden kişiye değişir.))
- De bedoeling is om terug te kijken naar het verleden en te leren hoe toenmalig zelfaangeleerde afweermechanismen ervoor zorgen dat er nu conflicten en moeilijkheden zijn in het heden. (Amaç geçmişe bakıp, o zaman kendi öğrenilen savunma mekanizmalarının bugün nasıl çatışma ve zorluk yarattığını anlamaktır.)
- Eén van de meest gebruikte vormen om het verleden te onderzoeken is psycho-analyse. (Geçmişi araştırmanın en yaygın yollarından biri psikanalizdir.)
- De bedoeling blijft om inzicht te krijgen in het eigen functioneren en nieuwe gedragingen / gezonde afweermechanismen aan te leren. (Amaç, kendi işleyişine içgörü kazanmak ve yeni davranışlar / sağlıklı savunma mekanizmaları öğrenmektir.)
- Zorgvragers met ontwikkelingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen komen hier o.a. voor in aanmerking. (Gelişim ve kişilik bozukluğu olan hastalar bu modele uygundur.)
- Dit is een veel vragend behandelingstraject en vraagt ook meer ziekte-inzicht in de problematiek dan in het supportief model. (Bu çok zorlayıcı bir tedavi sürecidir ve destekleyici modele göre daha fazla hastalık farkındalığı ister.)

B2) Afweermechanismen (savunma mekanizmaları)

- Afweermechanismen zijn onbewuste wijzen van beschermen tegen te heftige emoties. (Savunma mekanizmaları, aşırı yoğun duygulara karşı bilinçdışı korunma yollarıdır.)
- Iedereen gebruikt afweermechanismen om een emotioneel evenwicht te handhaven tussen wensen en verlangens enerzijds en geboden en verboden anderzijds. (Herkes, istek ve arzular ile kural ve yasaklar arasında duygusal dengeyi korumak için kullanır.)
- Ongezonde afweermechanismen (acting-out, dissociëren, rationaliseren, splitsen, ontkenning, onderdrukken,…) kunnen leiden tot psychopathologie. (Sağlıksız savunma mekanizmaları (davranışa vurma, ayrışma, mantığa bürüme, bölme, inkâr, bastırma…) ruhsal bozukluğa yol açabilir.)

Notların (okunuşu kesin değil): **kunnen rap kwaad** (çabuk kızarlar) · **rap emotioneel** (çabuk duygusallaşırlar) · **wit-zwart** (siyah-beyaz düşünme) · **manipuleren, onder druk geven** (manipüle eder, baskı yapar)

C) Het sociaal-therapeutische model

- In dit model wordt de focus gelegd op de relatie van de zorgvrager en de omgeving. (Bu modelde odak, hasta ile çevre arasındaki ilişkidir.)
- In tegenstelling tot het reconstructief model wordt niet gezocht welke destructieve patronen ik zelf geleerd heb, maar wordt onderzocht wat de impact is van de onderlinge wisselwerking in het samenleven met elkaar. (Yeniden yapılandırıcı modelin aksine, "hangi yıkıcı kalıpları öğrendim" aranmaz; birlikte yaşarken karşılıklı etkileşimin etkisi araştırılır.)
- Dit zegt iets over het derde onderdeel van de persoonlijkheid: aanpassing aan externe situaties (adaptief systeem). (Bu, kişiliğin üçüncü parçası hakkında bilgi verir: dış durumlara uyum (uyum

sistemi).)

- In dergelijk milieu worden "bewoners of gasten" in de mogelijkheid geplaatst om zoveel mogelijk sociale rollen op te nemen. (Böyle bir ortamda "sakinler veya misafirler" mümkün olduğunca çok sosyal rol alabilecekleri konuma getirilir.)
- Een bewoner begint op de laagste trede van de hiërarchie (bv. poetsen, bedden opmaken). Voldoet hij aan de verwachtingen, dan stijgt hij. (Sakin hiyerarşinin en alt basamağında başlar (örn. temizlik, yatak yapma). Beklentilere uyarsa yükselir.)

Notların: **Open staan en willen, kunt altijd genezen, wel lang project** (açık olmalı ve istemeli, iyileşme her zaman olur ama uzun bir proje) · **Altijd mensen die monopoleren in groep, kan ruzie maken** (grupta hep birileri baskın olur, tartışma çıkabilir) · **Die moeten terug naar de maatschappij, moet aangepast** (toplumun içine dönecekler, uyum şart)

EZBER TABLO
Supportief: executief systeem · leren, oefenen, trainen · hedef: zelfstandigheid (yürütücü sistem · öğrenme, alıştırma · bağımsızlık)
Reconstructief: defensief systeem · psychotherapie · hedef: inzicht (savunma sistemi · psikoterapi · içgörü)
Sociaal-therapeutisch: adaptief systeem · groepsleven, rollen · hedef: aanpassing (uyum sistemi · grup yaşamı, roller · topluma uyum)

2. Factoren psychopathologie ★ (korte casus)

- Korte casus: welke factoren spelen mee bij psychopathologie en welke bij functiestoornissen? (Kısa vaka: ruhsal bozuklukta ve işlev bozukluğunda hangi faktörler rol oynuyor?)

Nederlands	Türkçe
Endogene factoren: erfelijkheid, persoonlijkheid, leeftijd	**İçsel faktörler**: kalıtım, kişilik, yaş
Exogene factoren: ongeval, ziekte, operatie, verlies	**Dışsal faktörler**: kaza, hastalık, ameliyat, kayıp
Sociale en maatschappelijke factoren: werk, gezin, studie, rouw	**Sosyal ve toplumsal faktörler**: iş, aile, okul, yas
Iatrogene factoren: medicatie, opname, narcose	**Tedaviden kaynaklı faktörler**: ilaç, yatış, narkoz

Casus Wim (jouw notitie)

- Wim is 32 jaar, getrouwd, 3 kinderen, werkt en volgt momenteel een hogere opleiding; hij is zeer gemotiveerd. (Wim 32 yaşında, evli, 3 çocuklu, çalışıyor ve şu an yüksek okul okuyor; çok motive.)
- Kort geleden is zijn vader plotseling overleden. Hij is prikkelbaar, heeft een gebroken been na een ongeval, slaapt slecht en heeft angst. (Kısa süre önce babası ansızın öldü. Sinirli, kazadan bacağı kırık, kötü uyuyor ve kaygılı.)
- **Exogeen**: ongeval, gebroken been, slaaptekort. **Sociaal/maatschappelijk**: werk + studie + gezin, rouw. **Functiestoornissen**: prikkelbaarheid, angst, slaapstoornis. (**Dışsal**: kaza, kırık bacak, uykusuzluk. **Sosyal**: iş + okul + aile yükü, yas. **İşlev bozuklukları**: sinirlilik, kaygı, uyku bozukluğu.)

Casus 72 jaar

- Een man/vrouw van 72 jaar is opgenomen, galsteen verwijderd, onrustig, verward, 's nachts delier. (72 yaşında hasta yatırıldı, safra taşı alındı, huzursuz, karışık, geceleri deliryum.)
- **Exogeen**: operatie, opname. **Leeftijd** is risicofactor. **Iatrogeen**: medicatie, narcose, ziekenhuisomgeving. (**Dışsal**: ameliyat, yatış. **Yaş** risk faktörü. **Tedaviden kaynaklı**: ilaç, narkoz, hastane ortamı.)

Antwoordschema (Cevap şablonu): 1) wat zie ik (ne görüyorum) → 2) endogeen → 3) exogeen → 4) sociaal → 5) iatrogeen.

3. Functiestoornissen (Hoofdstuk 7)

- Iedere verpleegkundige komt tijdens de uitoefening van zijn beroep in contact met mensen met een verstoord psychisch functioneren. (Her hemşire mesleğini yaparken ruhsal işleyişi bozulmuş kişilerle karşılaşır.)
- Het is dus voor iedere verpleegkundige nuttig om kennis te hebben van de psychopathologie. (Bu yüzden her hemşirenin psikopatoloji bilgisine sahip olması yararlıdır.)
- Een verpleegkundige moet immers de tekenen van afwijkend functioneren kunnen herkennen en beschrijven. (Hemşire, olağan dışı işleyişin belirtilerini tanıyıp tanımlayabilmelidir.)
- Een overzicht van de functiestoornissen onder de patronen van Gordon is terug te vinden in klinisch onderwijs 3OGG. (İşlev bozukluklarının Gordon örüntülerine göre özeti klinik eğitim 3OGG'de bulunur.)
- **Symptoom**: een verschijnsel dat los kan worden gezien van andere (verschijnselen). (**Belirti**: diğerlerinden bağımsız görülebilen bir olgu.)
- **Syndroom**: een combinatie van verschillende symptomen. (**Sendrom**: birkaç belirtinin birleşimi.)

Syllabus'ta devamını (bellek, algı, düşünce vb.) kendi sayfalarından ekle; fotoğrafta yoktu.

4. Bewustzijnsstoornissen ★ (examen: uitleggen)

- Het woord "bewustzijn" heeft twee betekenissen, nl.: een "biologische" en een "psychische" betekenis. ("Bilinç" kelimesinin iki anlamı vardır: "biyolojik" ve "ruhsal" anlam.)
- Met "biologisch" bewustzijn verstaan we de toestand waarbij psychisch bewustzijn mogelijk is. Als het biologisch bewustzijn uitgeschakeld is, is psychisch bewustzijn niet mogelijk. (Biyolojik bilinç, ruhsal bilincin mümkün olduğu durumdur. Biyolojik bilinç kapalıysa ruhsal bilinç mümkün değildir.)
- "Psychisch" bewustzijn betekent dat we ons bewust worden. We komen tot een bepaald inzicht. (Ruhsal bilinç, bir şeyin farkına varmamız demektir; belli bir içgörüye ulaşırız.)
- Als we bewustzijnsstoornissen beschrijven, bedoelen we stoornissen in het biologisch bewustzijn, hetwelk door lichamelijke factoren bepaald wordt. (Bilinç bozukluklarından söz ederken, bedensel faktörlerle belirlenen biyolojik bilinç bozukluklarını kastederiz.)
- Er zijn verschillende gradaties in het (biologische) bewustzijn. (Biyolojik bilinçte farklı dereceler vardır.)
- Helderheid: de persoon is wakker, reageert, is soms zelfs actief, maar toch… Als hem plots iets gevraagd wordt (bv. hoe heet je?), dan duurt dit even. (Berraklık: kişi uyanık, tepki veriyor, bazen aktif bile; ama ona aniden bir şey sorulunca (örn. adın ne?) cevap gecikir. (Metin kesik; devamını syllabus'tan oku.))

Graad (derece)	Türkçe
Helder / wakker	Normal uyanıklık
Obnubilatie (?)	Hafif bulanıklık, cevap gecikir
Somnolentie	Uykulu
Sopor	Sadece güçlü uyarana tepki
Coma	Tepki yok

Dereceleri syllabus'taki sırayla karşılaştır. **Delier** de bu başlıkta.

5. Communicatie ★ (voorbeeld)

Nooit advies geven. Mensen zelf moeten beslissen. (Asla tavsiye verme. Kişi kendi karar vermeli.)

a) Man, 3 weken opgenomen (alcohol), weekend naar huis

- "Een man is nu 3 weken opgenomen met een zware alcoholverslaving. Na toestemming van de psychiater mag hij voor het eerst een weekend naar huis. Hij vraagt: wat moet ik doen, op weekend gaan of toch beter nog niet?" (Adam 3 haftadır ağır alkol bağımlılığıyla yatıyor. Psikiyatristin izniyle ilk kez hafta sonu eve gidebilir. Soruyor: ne yapmalıyım, gideyim mi yoksa daha erken mi?)
- **Waarom denk je van niet?** (**Neden gitmeyeceğini düşünüyorsun?** (nedeni sor))
- Vraag duidelijk zoeken naar de oorzaak. (Nedeni net bir şekilde araştır.)
- Situatie van de thuisomgeving bespreken. (Ev ortamını konuş.)
- Eerst horen, dan proberen te kaderen. (Önce dinle, sonra çerçevele.)
- Samen een probleemoplossing opstellen. (Birlikte bir çözüm planı kur.)
- Waar is het gevaar of de angst? (Tehlike ya da korku nerede?)

b) Vrouw met depressie, relatieproblemen

- "Een vrouw is opgenomen met een depressie die het gevolg is van relatieproblemen met haar partner. Ze vraagt jou of ze weg moet gaan bij haar man of niet." (Kadın, partneriyle ilişki sorunları yüzünden gelişen depresyonla yatıyor. Sana kocasından ayrılıp ayrılmaması gerektiğini soruyor.)
- **Ik hoor dat u voor een keuze staat in uw relatie.** (**Duyuyorum ki ilişkinizle ilgili bir seçimle karşı karşıyasınız.**)
- Nooit advies geven. Mensen zelf moeten beslissen. (Asla tavsiye verme. Kişi kendi karar vermeli.)

Laatste herhaling (Son tekrar): 3 modellen + systeem · ik-opbouw / ik-versterking / ik-behoud · 3 fasen antiregressief · afweermechanismen · 4 factoren · bewustzijn (2 betekenissen) · symptoom vs syndroom · nooit advies geven.